

Prescripción de ejercicio en EPOC: capacidad funcional, disnea y fuerza periférica

Síntesis clínica · 2026-09-14

Resumen ejecutivo

La rehabilitación pulmonar basada en ejercicio mejora capacidad de marcha, disnea y calidad de vida en EPOC. La clave está en combinar entrenamiento de resistencia, fuerza de miembros inferiores y estrategias de manejo de la disnea.

Esta síntesis clínica de Metabolic Fitness Academy traduce evidencia contemporánea en fisiología del ejercicio aplicada a criterios prácticos para médicos, kinesiólogos y fisiólogos clínicos en Latinoamérica.

Limitaciones fisiológicas al esfuerzo

En EPOC coexisten limitación ventilatoria, descondicionamiento muscular e hiperinflación dinámica. La disnea no es solo 'falta de aire': refleja desacoplamiento entre demanda ventilatoria y capacidad. Por ello, programas solo aeróbicos sin trabajo de fuerza suelen dejar un déficit periférico importante.

Aeróbico, intervalado y fuerza

El continuo o intervalado (según tolerancia) mejora resistencia. Intervalos cortos permiten acumular trabajo con menor disnea pico. La fuerza de cuádriceps y glúteos eleva la reserva funcional para caminar y subir escaleras. Monitoree saturación, RPE de disnea y recuperación entre series.

Seguridad y progresión

Defina umbrales de desaturación con el equipo médico, use oxigenoterapia cuando esté indicada y enseñe estrategias (pursed lips, pausas activas). Progrese primero duración/frecuencia y luego intensidad. La educación en automanejo de exacerbaciones es parte del plan.

Implicaciones clínicas

Combine aeróbico/intervalado + fuerza de MMI, monitoree SpO2 y disnea, y coordine con rehabilitación pulmonar y médico tratante.

Referencias y marcos de evidencia

- GOLD strategy for COPD diagnosis, management and prevention.
- ATS/ERS statements on pulmonary rehabilitation.